ORL · CO-01

# Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS

**ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023**
échographie · indications de cytoponction · lexique I-TIRADS

## EU-TIRADS (ETA 2017, REPRIS PAR L'ETA 2023) · SYSTÈME DE RÉFÉRENCE EN EUROPE

| CATÉGORIE | ASPECT ÉCHOGRAPHIQUE | RISQUE DE MALIGNITÉ | CYTOPONCTION |
|---|---|---|---|
| EU-TIRADS 1 | Pas de nodule | — | — |
| EU-TIRADS 2 | Bénin : kyste pur, nodule entièrement spongiforme | ≈ 0 % | Non (sauf évacuation) |
| EU-TIRADS 3 | Faible risque : ovale, contours réguliers, **iso- ou hyperéchogène**, aucun signe de haut risque | 2–4 % | **> 20 mm** |
| EU-TIRADS 4 | Risque intermédiaire : **modérément hypoéchogène**, aucun signe de haut risque | 6–17 % | **> 15 mm** |
| EU-TIRADS 5 | Haut risque : **au moins 1** signe parmi forme non ovale (plus haut que large), contours irréguliers, microcalcifications, hypoéchogénicité marquée | 26–87 % | **> 10 mm** |

### Points clés ETA 2023

- EU-TIRADS 5 de 5–10 mm : surveillance active ou cytoponction selon le contexte (localisation, patient)
- Toujours cytoponctionner une adénopathie suspecte, quelle que soit la taille du nodule
- EU-TIRADS 3 < 20 mm : 5–10 mm pas de suivi ; 10–20 mm contrôle à 3–5 ans

### Nouvelle cytoponction si

- 1er prélèvement non diagnostique (sauf kyste solitaire)
- Bethesda III
- Discordance : échographie à haut risque et cytologie bénigne
- Croissance significative : ≥ 20 % sur au moins 2 diamètres avec ≥ 2 mm, ou volume > 50 %, ou signes compressifs

## ACR TI-RADS (2017) · SCORE PAR POINTS

| COMPOSITION | ÉCHOGÉNICITÉ | FORME | CONTOURS | FOYERS ÉCHOGÈNES (ADDITIONNER) |
|---|---|---|---|---|
| Kystique ou spongiforme **0**<br>Mixte **1**<br>Solide **2** | Anéchogène **0**<br>Hyper- ou isoéchogène **1**<br>Hypoéchogène **2**<br>Très hypoéchogène **3** | Plus large que haut **0**<br>Plus haut que large **3** | Réguliers ou flous **0**<br>Lobulés ou irréguliers **2**<br>Extension extrathyroïdienne **3** | Aucun, queue de comète **0**<br>Macrocalcifications **1**<br>Calcifications périphériques **2**<br>Foyers ponctiformes **3** |

| NIVEAU | POINTS | CYTOPONCTION | SURVEILLANCE |
|---|---|---|---|
| TR1 bénin | 0 | Non | Non |
| TR2 non suspect | 2 | Non | Non |
| TR3 peu suspect | 3 | **≥ 2,5 cm** | ≥ 1,5 cm : à 1, 3 et 5 ans |
| TR4 modérément suspect | 4–6 | **≥ 1,5 cm** | ≥ 1,0 cm : à 1, 2, 3 et 5 ans |
| TR5 très suspect | ≥ 7 | **≥ 1,0 cm** | ≥ 0,5 cm : tous les ans pendant 5 ans |

Croissance significative (ACR) : ≥ 20 % et ≥ 2 mm sur 2 diamètres, ou volume ≥ 50 %. Au maximum 2 cytoponctions (les 2 scores les plus élevés) et suivi de 4 nodules au maximum.

## I-TIRADS · LEXIQUE INTERNATIONAL (RADIOLOGY 2023)

### Phase I · lexique consensuel

- Consensus international endossé par ACR, AME, ATA, ETA et sociétés coréennes (KSTR/KTA)
- **6 catégories de descripteurs** : composition, échogénicité, forme, contours, extension extrathyroïdienne, foyers échogènes (calcifications)
- Termes et définitions **unifiés** (kystique, spongiforme, hypoéchogène marqué…) + lexique des **ganglions cervicaux**

### Phase II · en cours

- Système international complet de stratification du risque **non encore publié**
- Objectif : une même probabilité de malignité et des seuils de cytoponction harmonisés mondialement
- En attendant : un seul système par compte rendu (EU-TIRADS **ou** ACR TI-RADS)

## COMPTE RENDU

**Pour chaque nodule**
localisation (lobe, tiers), 3 diamètres, description complète du lexique

**Score**
EU-TIRADS (ou ACR TI-RADS si choix local) avec la conduite à tenir

**Ganglions**
secteurs cervicaux, signes suspects : microcalcifications, kystisation,

**Système**
indiquer le système utilisé ; ne pas mélanger les deux

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | hyperéchogénicité, vascularisation périphérique | |

ORL · CO-01

# Nodule thyroïdien · EU-TIRADS / ACR TI-RADS

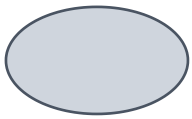
(suite)

**ETA 2023 · ACR TI-RADS 2017 · I-TIRADS 2023**

échographie · indications de cytoponction · lexique I-TIRADS

## ATLAS VISUEL

### Signes échographiques clés



axe horizontal > vertical

**Plus large que haut**

0 point



vertical > horizontal

**Plus haut que large**

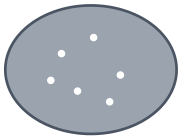
+3 · signe EU-TIRADS 5



lobulés ou irréguliers

**Contours irréguliers**

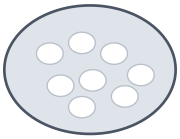
+2 · EU-TIRADS 5



foyers ponctiformes

**Microcalcifications**

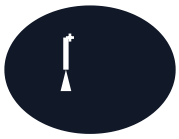
+3 · EU-TIRADS 5



microkystes > 50 %

**Spongiforme**

bénin · 0 point



artefact en queue de comète

**Queue de comète**

colloïde · 0 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**ACR TI-RADS**
Radiopaedia · points et seuils
radiopaedia.org/articles/acr-thyroid-imaging-rep

**EU-TIRADS**
Radiopaedia · catégories européennes
radiopaedia.org/articles/european-thyroid-associ

**Nodule thyroïdien : démarche**
Radiopaedia · approche pratique
radiopaedia.org/articles/thyroid-nodules-an-appr

**Carcinome papillaire**
Radiopaedia · aspects échographiques
radiopaedia.org/articles/papillary-thyroid-cance

**ACR TI-RADS (site officiel)**
ACR · lexique et documents
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

**I-TIRADS · lexique international 2023**
Radiology · consensus international
pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.231481

**Sources :** ETA 2023 Guidelines thyroid nodules – www.afthy.fr/wp-content/uploads/2024/11/ETA-2023-GUIDELINES-... · ACR TI-RADS White Paper 2017 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28372962/ · ACR TI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · I-TIRADS lexicon (Radiology 2023) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.231481